Docs On The Road
Construisons ensemble une santé qui vient à vous.

PROCESSUS MEDICAL

ORGANISATION DE LA MÉDECINE GÉNÉRALE ET DE LA MÉDECINE DE COORDINATION

www.docsontheroad.fr

TACHES À RÉALISER D'UNE MANIÈRE GÉNÉRALE

1. **Les infirmières :**

Intégration (dans la plateforme) des derniers documents utiles (DLU et dernières ordonnances, le consentement du patient).

- *Documents modifiables (.doc): les télécharger directement dans ce format*
- *Documents non modifiables (.pdf) ou au format papier : les scanner, puis les télécharger pour chaque patient*

2. **Les rééducateurs, la neuropsychologue, la diététicienne…**

Peuvent faire des demandes en direct au médecin, un accès et une formation sont utiles pour optimiser les échanges et gagner du temps à tous

Mise à jour d'une page de synthèse pour chaque résident

- *Documents modifiables (.doc): les télécharger directement dans ce format*
- *Documents non modifiables (.pdf) ou au format papier : les scanner, puis les télécharger pour chaque patient*

3. **Les aides soignantes :**

Mise à jour de la feuille de suivi hebdomadaire du transit

- *Documents modifiables (.doc): les télécharger directement dans ce format*
- *Documents non modifiables (.pdf) ou au format papier : les scanner, puis les télécharger pour chaque patient*

LES SITUATIONS MÉDICALES

SITUATION 1	SITUATION 2	SITUATION 3
Urgence vitale ou devant être prise en charge dans la journée*	Urgence « différable » à 48-72H	Consultation planifiée
1. Vous faites comme avant, c'est-à-dire sans médecin : SAMU, SAU. 2. Vous prévenez le médecin afin qu'il soit informé, même s'il ne peut pas être disponible.	1. Prévenir le médecin (sms). 2. Préparer le bilan (voir modalités).* 3. En cas d'aggravation, revenir à la situation 01.	1. Respecter l'ordre des consultations (sauf urgence médicale). 2. Préparer le bilan avant consultation. 3. Les patients sont préparés et installés sur la table d'examen de l'infirmerie.

Si doute sur la situation (urgent, très urgent ? => appel SAMU pour régulation)

• Si la situation n'est pas urgente, mais non planifiée sur les créneaux habituels, préparez la consultation sur la plate forme avec un maximum de relevés informatifs et visuels selon la problématique (créer toujours une nouvelle consultation).
• Par la plateforme de télémédecine (traitement assuré sous 72h ouvrés)
• Le mail n'est pas le bon moyen de contacter le médecin pour une situation médicale

PRÉPARATION DU BILAN MÉDICAL

Quand ?*Avant que le médecin ne soit présent.*

Comment ? *La préparation est réalisée au travers de la solution de télémédecine.*

Intérêt ? *La préparation permet d'optimiser le temps consacré à la consultation et d'accélérer la prise de décision médicale.*

Quelle préparation ? *IDE*

Créer une consultation infirmière :

- *Indiquer le motif de l'observation (consultation planifiée ou événement), en précisant le contexte.*
- *Renseigner les mesures biométriques récentes ou réalisées le jour même selon la situation : fréquence respiratoire (FR), saturation en oxygène (SpO_2), fréquence cardiaque (FC), tension artérielle (TA), température, bandelette urinaire (BU) et/ou dextro si nécessaire.*
- *Si aucun ECG récent (moins d'un an) n'est disponible, en réaliser un et déposer également le précédent sur la plateforme afin de permettre la comparaison.*
- *Prendre les photographies (par exemple : éruption cutanée, otoscopie) ou les vidéos (par exemple : mouvements anormaux, manifestations respiratoires) utiles à la décision médicale et à l'orientation diagnostique. Si un stéthoscope connecté est disponible, réaliser également les enregistrements nécessaires.*
- *Envoyer la consultation infirmière afin que le médecin dispose de l'ensemble des informations avant la téléconsultation avec l'équipe et le patient.*
- *Intégrer dans le porte-documents, au minimum : la DLU (fiche médicale) et la dernière ordonnance.*

AS

Remplir la feuille de transmission de la semaine en cours afin d'identifier les évolutions récentes pouvant orienter les investigations et le diagnostic, notamment :
le comportement ; le transit (selles) ; les urines (odeur, aspect, anomalies) ; les anomalies cutanées (plis, escarres, rougeurs, etc.) ; l'alimentation (perte d'appétit, fausses routes, difficultés alimentaires, etc.) ; tout autre changement clinique significatif.

APRÈS CHAQUE INTERVENTION DU MÉDECIN (SUIVI)

1. Marquer « Vu et traité » si le sujet a été pris en charge

a) Marquer « **Vu** » lorsque les prescriptions ou les commentaires/conclusions ont été consultés.
b) Marquer « **Traité** » lorsque les prescriptions ont été réalisées, les rendez-vous pris et les autres actions nécessaires effectuées.
c) Sur la consultation, il est possible d'indiquer, à l'aide d'un code couleur (vert, orange ou rouge), la situation, d'ajouter un message et de créer un rappel pour soi-même.

2. Prévenir lorsque les résultats (imagerie, laboratoire, biologie, etc.) **sont disponibles**

a) Il est nécessaire, même si les résultats sont disponibles sur Netsoins, de joindre le document officiel du laboratoire au format PDF dans le fil de la consultation (via les commentaires). Cela permet d'assurer la traçabilité et de garantir au médecin que les résultats sont bien ceux du patient et qu'ils sont complets.
b) Il est également recommandé de récupérer les courriers et comptes rendus (CR) et de les joindre au fil de la consultation via les commentaires.
c) Si l'établissement dispose d'un logiciel médical, les informations peuvent être liées à l'observation afin de prévenir le médecin de l'arrivée de nouveaux résultats ou documents.

CONTACT

+33 6 63 41 65 81

morvan.b@docsontheroad.fr

www.docsontheroad.fr

Docs On The Road

Construisons ensemble une santé qui vient à vous.